



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 34

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz über einen Landesfonds zur
Sicherung und Rekommunalisierung von
Krankenhäusern im Freistaat
Ostdeutschland und zur Änderung des
Ostdeutschen Krankenhausgesetzes**

Seite 2

Gesetz

über einen Landesfonds zur Sicherung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern im Freistaat Ostdeutschland und zur Änderung des Ostdeutschen Krankenhausgesetzes

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23.
März 2026 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Gesetzes über einen Landesfonds zur Sicherung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern im Freistaat Ostdeutschland

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über einen Landesfonds zur Sicherung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern im Freistaat Ostdeutschland (Ostdeutsches Krankenhaussicherungs- und Rekommunalisierungsfondsgesetz – OstKHFondsG)

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Errichtung des Fonds

- (1) Der Freistaat Ostdeutschland errichtet einen Landesfonds zur Sicherung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern als Sondervermögen des Landes ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- (2) Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des Landes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.
- (3) Aus dem Fonds dürfen nur Leistungen nach Maßgabe dieses Gesetzes erbracht werden.

§ 2**Zweck des Fonds**

(1) Zweck des Fonds ist es,

1. die wohnortnahe stationäre und sektorenübergreifende Versorgung der Bevölkerung zu sichern,
2. versorgungsnotwendige Krankenhausstandorte und besonders zu sichernde Leistungsbereiche zu erhalten,
3. die Übernahme, Stabilisierung, Rekommunalisierung und gemeinwohlorientierte Fortführung wirtschaftlich gefährdeter Krankenhäuser oder Krankenhausstandorte zu ermöglichen,
4. die Bildung interkommunaler und regionaler Klinikverbünde sowie kooperative Versorgungsstrukturen zu unterstützen,

5. Transformations-, Sanierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen zu fördern, die für die dauerhafte Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung erforderlich sind.

(2) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Belange dünn besiedelter Räume und strukturschwacher Regionen besonders zu berücksichtigen.

(3) Leistungen aus dem Fonds dürfen nicht dem Zweck dienen, renditeorientierte Geschäftsmodelle ohne nachhaltigen Versorgungsnutzen zu stabilisieren.

§ 3**Begriffsbestimmungen**

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. versorgungsnotwendig ein Krankenhaus, ein Krankenhausstandort oder ein Leistungsbereich, der
 - a. im Krankenhausplan des Freistaates Ostdeutschland mit bedarfsdeckender oder bedarfswesentlicher

- Funktion ausgewiesen ist
oder
b. nach § 10a des
Ostdeutschen
Krankenhausgesetzes als
besonders
sicherungsbedürftig
festgestellt worden ist;
2. Rekommunalisierung der
unmittelbare oder mittelbare
Erwerb von Anteilen,
Vermögensgegenständen oder
dem Krankenhausbetrieb
dienenden Rechten durch
Landkreise, kreisfreie Städte,
kommunale Zweckverbände,
kommunale Unternehmen oder
das Land zur Sicherung der
Krankenhausversorgung;
3. gemeinwohlorientierter Träger ein
Träger, der
a. nach seiner Satzung,
seinem
Gesellschaftsvertrag oder
einer öffentlich-rechtlichen
Bindung vorrangig Zwecke
der
Gesundheitsversorgung
verfolgt,
b. Gewinne während der
Bindungsfrist nicht oder
nur nach Maßgabe dieses
- Gesetzes ausschütten darf
und
c. die Anforderungen des §
16 erfüllt;
4. Trägersausstieg die beabsichtigte
oder eingetretene Aufgabe der
Trägerschaft, die Veräußerung
einer beherrschenden
Beteiligung, die Veräußerung
wesentlicher Betriebsgrundlagen
oder ein sonstiger Vorgang, der
die Erfüllung des
Versorgungsauftrags ernstlich
gefährdet;
5. Restrukturierungs- und
Fortführungskonzept ein
belastbares, zeitlich gegliedertes
Konzept zur medizinischen,
organisatorischen, personellen
und wirtschaftlichen
Stabilisierung oder Umgestaltung
eines Krankenhauses, eines
Standortes oder eines
Verbundes.

Abschnitt 2

Fondsbewirtschaftung

§ 4

Stellung im Rechtsverkehr, Verwaltung und Aufsicht

- (1) Der Fonds ist nicht rechtsfähig.

(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Staatsministerium bewirtschaftet den Fonds. Das für die Finanzen zuständige Staatsministerium verwaltet das Sondervermögen und führt dessen Vermögens- und Finanzrechnung.

(3) Entscheidungen über Leistungen aus dem Fonds bedürfen des Einvernehmens des für die Finanzen zuständigen Staatsministeriums, soweit in der nach § 20 zu erlassenden Rechtsverordnung nichts Näheres bestimmt ist.

(4) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Fonds.

§ 5

Finanzierung des Fonds

(1) Dem Fonds werden zugeführt:

1. Mittel aus dem Landeshaushalt,
2. Mittel, die dem Fonds durch Haushaltsgesetz aus Kreditmarktmitteln oder aus Rücklagen des Landes zugewiesen werden,

3. Rückzahlungen, Zinsen, Tilgungen, Erlöse aus Veräußerungen, Dividenden und sonstige Rückflüsse aus Maßnahmen nach diesem Gesetz,

4. Leistungen Dritter, insbesondere des Bundes, anderer Länder, der Europäischen Union oder kommunaler Gebietskörperschaften,

5. Erträge des Fondsvermögens.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Ausstattung des Fonds besteht nicht.

(3) Die Mittel des Fonds sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

§ 6

Fondsbeirat

(1) Beim für das Gesundheitswesen zuständigen Staatsministerium wird ein Fondsbeirat gebildet.

(2) Dem Fondsbeirat gehören an:

1. je zwei Vertreter des für das Gesundheitswesen

zuständigen
Staatsministeriums und
des für die Finanzen
zuständigen
Staatsministeriums,

2. ein Vertreter des für
Inneres zuständigen
Staatsministeriums,

3. zwei Vertreter der
kommunalen
Spitzenverbände,

4. ein Vertreter der
Krankenhausgesellschaft
Ostdeutschland,

5. je ein Vertreter der
Landesverbände der
Krankenkassen und des
Verbandes der
Ersatzkassen,

6. ein Vertreter des
Landesausschusses des
Verbandes der Privaten
Krankenversicherung,

7. ein Vertreter der
Arbeitnehmerseite aus
dem Krankenhausbereich.

(3) Der Fondsbeirat berät über
Grundsätze der
Fondsbewirtschaftung, Prioritäten
der Mittelverwendung und Fälle

von besonderer Bedeutung. Er
kann Empfehlungen abgeben;
die Entscheidung trifft die
zuständige Stelle nach diesem
Gesetz.

(4) Das Nähere regelt die
Rechtsverordnung nach § 20.

Abschnitt 3

Leistungen des Fonds

§ 7

Begünstigte

(1) Leistungen aus dem Fonds
können erhalten:

1. Landkreise und kreisfreie
Städte,

2. kommunale
Zweckverbände,

3. Bezirke

4. kommunale Unternehmen
und kommunal
beherrschte
Krankenhausgesellschaften

,

5. gemeinwohlorientierte
Träger,

6. eine vom Land
beherrschte

Beteiligungsgesellschaft
nach § 12.

(2) Private Träger sind nur begünstigt, soweit sie zugleich gemeinwohlorientierte Träger im Sinne des § 3 Nummer 3 sind und sich für die gesamte Bindungsfrist den Anforderungen dieses Gesetzes unterwerfen.

§ 8

Förderfähige Maßnahmen

(1) Aus dem Fonds können insbesondere gefördert oder finanziert werden:

1. Investitionsmaßnahmen an versorgungsnotwendigen Krankenhäusern oder Krankenhausstandorten,
2. Überbrückungshilfen zur Abwendung akuter Versorgungslücken,
3. Zuschüsse und Darlehen für die kommunale oder gemeinwohlorientierte Übernahme von Krankenhäusern, Krankenhausstandorten, Gesellschaftsanteilen oder

wesentlichen Vermögensgegenständen,

4. die Finanzierung von Anteilserwerben, Asset-Deals sowie der dafür erforderlichen Transaktions- und Beratungskosten,
5. Transformations-, Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen einschließlich Digitalisierungs-, Kooperations- und Verbundvorhaben,
6. Maßnahmen zur Bildung, Erweiterung oder Stabilisierung interkommunaler Klinikverbünde,
7. die vorübergehende Finanzierung des Betriebs versorgungsnotwendiger Leistungsbereiche, soweit dies zur Sicherung der Versorgung unerlässlich ist.

(2) Nicht gefördert werden Maßnahmen, die überwiegend der bloßen Vermögensmehrung des Trägers, der Refinanzierung

vergangener Ausschüttungen
oder einer nicht
versorgungsbezogenen
Expansion dienen.

Krankenhausgesetzes
bezeichnete
Leistungsbereiche.

§ 9

Besondere Sicherungsleistungen

(1) Für besonders
sicherungsbedürftige
Leistungsbereiche können
Sicherungsleistungen gewährt
werden, wenn deren dauerhafte
Vorhaltung für die Versorgung
der Bevölkerung erforderlich ist
und eine auskömmliche
Finanzierung durch andere
Finanzierungsinstrumente nicht
erreichbar ist.

(2) Besonders sicherungsbedürftige
Leistungsbereiche sind
insbesondere:

1. Geburtshilfe,
2. Pädiatrie,
3. Notfallversorgung,
4. ländliche
Grundversorgung,
5. weitere im
Krankenhausplan oder in
einer Feststellung nach §
10a des Ostdeutschen

(3) Sicherungsleistungen setzen eine
nachvollziehbare Kalkulation der
Vorhaltekosten, ein Testat zur
wirtschaftlichen Lage und ein
Konzept zur Einbindung in die
regionale Versorgungsstruktur
voraus.

§ 10

Fördervoraussetzungen

(1) Leistungen aus dem Fonds setzen
voraus, dass

1. das Krankenhaus, der
Krankenhausstandort oder
der Leistungsbereich
versorgungsnotwendig ist,
2. eine wirtschaftliche
Gefährdung, ein
Schließungsrisiko, ein
Trägerausstieg oder ein
sonstiger erheblicher
Stabilisierungsbedarf
vorliegt,
3. die Maßnahme geeignet
ist, die Versorgung
dauerhaft oder jedenfalls
für einen

planungsrechtlich
erheblichen Zeitraum zu
sichern,

4. ein Restrukturierungs- und
Fortführungskonzept nach
§ 14 vorliegt,

5. der Begünstigte die
Anforderungen des § 16
erfüllt oder sich hierzu
rechtsverbindlich
verpflichtet und

6. andere
Finanzierungsmögli-
cheite
n nicht ausreichen oder
nicht rechtzeitig verfügbar
sind.

(2) Leistungen dürfen nur gewährt
werden, wenn auf der Grundlage
einer Gesamtwürdigung eine
positive Versorgungsprognose
besteht. Diese kann auch dann
vorliegen, wenn der bisherige
Krankenhausbetrieb in eine
andere tragfähige
Versorgungsstruktur überführt
werden soll.

(3) Bei Leistungen nach § 8 Absatz 1
Nummer 3 und 4 ist zusätzlich
nachzuweisen, dass die
Übernahme wirtschaftlich
vertretbar und zur

Versorgungssicherung
erforderlich ist.

§ 11

Art, Umfang und Ausgestaltung der Leistungen

(1) Leistungen aus dem Fonds
können als Zuschuss, Darlehen,
Bürgschaft, stille Beteiligung,
Erwerb von Anteilen, Erwerb von
Vermögensgegenständen oder in
anderer geeigneter
Finanzierungsform gewährt
werden.

(2) Zuschüsse sind insbesondere
zulässig für

1. Sicherungsleistungen nach
§ 9,
2. Investitionen, die der
Erfüllung des
Versorgungsauftrags
dienen,
3. Transformationskosten,
4. Kosten der Vorbereitung
und Umsetzung einer
Übernahme oder
Verbundbildung.

(3) Darlehen und sonstige
rückzahlbare Leistungen sind
vorrangig einzusetzen, soweit der

Sicherungszweck hierdurch mit gleicher Wirksamkeit erreicht werden kann.

(4) Leistungen können mit kommunalen Eigenanteilen, Beiträgen anderer öffentlicher Stellen oder Drittmitteln kombiniert werden.

(5) Umfang und Ausgestaltung der Leistung richten sich nach dem zur Zielerreichung erforderlichen Maß. Eine Überkompensation ist auszuschließen.

§ 12

Landeseigene Sicherungsbeteiligung

(1) Steht für einen versorgungsnotwendigen Standort oder Leistungsbereich nicht rechtzeitig ein kommunaler oder sonstiger gemeinwohlorientierter Träger zur Verfügung, kann das Land die Aufgabe vorübergehend durch eine juristische Person des Privatrechts wahrnehmen lassen, an der es unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit der Anteile oder Stimmrechte hält.

(2) Die landeseigene Beteiligungsgesellschaft kann insbesondere

1. Anteile an Krankenhausgesellschaften erwerben oder halten,
2. Vermögensgegenstände und betriebsnotwendige Rechte erwerben oder pachten,
3. Übergangs- und Interimsbetriebsmodelle umsetzen,
4. Standorte oder Leistungsbereiche an kommunale oder gemeinwohlorientierte Träger weiterübertragen.

(3) Die Beteiligung des Landes ist auf das zur Versorgungssicherung Erforderliche und grundsätzlich auf einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu befristen. Eine einmalige Verlängerung um bis zu fünf weitere Jahre ist zulässig, wenn eine geordnete Rückübertragung andernfalls gefährdet wäre.

(4) Vor Entscheidungen von besonderer finanzieller oder

struktureller Bedeutung sind der Haushaltsausschuss und der für Gesundheit zuständige Ausschuss des Landtags zu unterrichten.

Abschnitt 4

Verfahren und Bindungen

§ 13

Antrag, Initiativverfahren und Auswahl

- (1) Leistungen aus dem Fonds werden auf Antrag gewährt. Antragsberechtigt sind die in § 7 genannten Begünstigten.
- (2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Staatsministerium kann ein Verfahren von Amts wegen einleiten, wenn ihm Tatsachen bekannt werden, die auf eine erhebliche Gefährdung eines versorgungsnotwendigen Krankenhauses, Standortes oder Leistungsbereiches schließen lassen.
- (3) Vor der Entscheidung sind die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften, der Krankenhausträger, die Krankenhausplanungsträger sowie die nach dem

Krankenhausfinanzierungsgesetz unmittelbar Beteiligten zu hören, soweit dies nach den Umständen des Einzelfalles möglich und zweckmäßig ist.

- (4) Bei konkurrierenden Vorhaben sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. der Beitrag zur Versorgungssicherung,
2. die Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit der Lösung,
3. die regionale Ausgewogenheit,
4. die Stärkung kommunaler oder gemeinwohlorientierter Trägerschaft,
5. die Qualität des Restrukturierungs- und Fortführungskonzepts.

§ 14

Restrukturierungs- und Fortführungskonzept

- (1) Das Restrukturierungs- und Fortführungskonzept muss mindestens enthalten:

1. die Ausgangslage und Ursachen der Gefährdung,
 2. die medizinische und versorgungsbezogene Zielstruktur,
 3. die personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Maßnahmen,
 4. einen Zeit- und Finanzierungsplan,
 5. Aussagen zur Einbindung in die regionale Versorgungsstruktur und
 6. eine Risikobewertung.
- (2) Das zuständige Staatsministerium kann die Vorlage ergänzender Unterlagen, insbesondere von Wirtschaftsprüferberichten, Unternehmensbewertungen, Due-Diligence-Berichten, Sanierungsgutachten und kommunalrechtlichen Beschlüssen verlangen.
- § 15**
- Förderentscheidung,**
- Nebenbestimmungen und**
- Zweckbindung**
- (1) Leistungen aus dem Fonds werden durch schriftlichen Bescheid oder, soweit dies zweckmäßig ist, durch öffentlich-rechtlichen Vertrag gewährt.
 - (2) Die Leistung ist insbesondere mit Nebenbestimmungen zu versehen über
 1. den Verwendungszweck,
 2. Meilensteine der Umsetzung,
 3. Berichtspflichten,
 4. Zweckbindungsfristen,
 5. Rückzahlungs-, Verzinsungs- und Sicherungsregelungen,
 6. Zustimmungsvorbehalte für wesentliche Strukturmaßnahmen.
 - (3) Die Zweckbindungsfrist beträgt bei investiven Maßnahmen regelmäßig zehn Jahre, bei Anteils- oder Vermögenserwerben regelmäßig fünf Jahre; in begründeten Fällen kann eine längere Frist bestimmt werden.

§ 16**Gemeinwohlbindung, Tariftreue,
Mitbestimmung und
Ausschüttungsbeschränkung**

(1) Begünstigte haben während der Bindungsfrist

1. den Versorgungsauftrag und die mit der Förderung verfolgten Sicherungsziele zu erfüllen,
2. Tarifverträge des öffentlichen Dienstes oder diesen in wesentlichen Arbeitsbedingungen gleichwertige tarifvertragliche Regelungen anzuwenden,
3. gesetzliche und kollektivrechtliche Mitbestimmungsrechte zu wahren und betriebliche Interessenvertretungen nicht zu beeinträchtigen.

(2) Während der Bindungsfrist dürfen Gewinne, Gewinnvorträge, Liquidationserlöse oder vergleichbare Vermögensvorteile nicht an Anteilseigner oder Mitglieder ausgeschüttet werden. Zulässig bleiben marktübliche

Vergütungen für tatsächlich erbrachte Leistungen sowie vertraglich vereinbarte Tilgungs- und Zinsleistungen aus rückzahlbaren Fondsleistungen.

(3) Satzung, Gesellschaftsvertrag oder sonstige maßgebliche Rechtsgrundlagen sind vor Auszahlung der Leistung an die Anforderungen dieses Paragraphen anzupassen, soweit dies erforderlich ist.

§ 17**Rückforderung, Verzinsung und
Rückflüsse**

- (1) Die Leistung ist ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn
1. sie zweckwidrig verwendet wird,
 2. eine Fördervoraussetzung nachträglich entfällt und der Sicherungszweck nicht mehr erreicht wird,
 3. Auflagen oder Bindungen nach § 15 oder § 16 verletzt werden,
 4. unrichtige oder unvollständige Angaben für die Bewilligung wesentlich waren.

(2) Rückzahlungsansprüche können verzinst werden. Das Nähere regelt der Bewilligungsbescheid oder die Rechtsverordnung nach § 20.

(3) Rückflüsse aus Beteiligungen, Veräußerungen, Tilgungen und Zinsen fließen dem Fonds zu.

§ 18

Berichtspflichten, Transparenz und Unterrichtung des Landtags

(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Staatsministerium legt dem Landtag jährlich einen Bericht über die Mittelverwendung, die geförderten Maßnahmen, die eingegangenen Beteiligungen, die Rückflüsse und die wesentlichen Wirkungen des Fonds vor.

(2) Der Bericht soll nach Regionen, Maßnahmearten und Trägergruppen gegliedert sein. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren.

(3) Über Maßnahmen nach § 12 von besonderer finanzieller oder

struktureller Bedeutung ist der Landtag unverzüglich zu unterrichten.

§ 19

Verhältnis zum Recht der Europäischen Union

(1) Leistungen nach diesem Gesetz dürfen nur gewährt werden, soweit sie mit dem Recht der Europäischen Union, insbesondere mit dem Beihilferecht, vereinbar sind.

(2) Soweit Leistungen als Ausgleich für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt werden, sind der Betrauungsakt, die Ausgleichsparameter, die Kontrollmechanismen und die Vorkehrungen zur Vermeidung einer Überkompensation im Bewilligungsbescheid oder in einem gesonderten Rechtsakt festzulegen.

(3) Leistungen, deren Gewährung der beihilferechtlichen Anmeldung oder Genehmigung bedarf, dürfen erst nach Vorliegen der beihilferechtlichen

Voraussetzungen bewilligt oder
ausgezahlt werden.

Verzinsung und
Sicherheiten,

Abschnitt 5

Schlussbestimmungen

§ 20

Verordnungsermächtigung

Das für das Gesundheitswesen
zuständige Staatsministerium wird
im Einvernehmen mit dem für die
Finanzen zuständigen
Staatsministerium ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das
Nähere zu regeln über

1. das Verfahren der
Antragstellung und
Bewilligung,
2. Inhalt, Form und Prüfung
des Restrukturierungs- und
Fortführungskonzepts,
3. die Beteiligung des
Fondsbeirats,
4. die Ausgestaltung von
Zuschüssen, Darlehen,
Bürgschaften und
Beteiligungen,
5. die Bemessung von
Zweckbindungsfristen,

6. Berichtspflichten und
Transparenzstandards,

7. das Verfahren der
beihilferechtlichen
Prüfung und
Dokumentation.

Artikel 2

Änderung des Ostdeutschen Krankenhausgesetzes

Das Ostdeutsche Krankenhausgesetz
vom 15. Dezember 2022 (SächsGVBl. S.
752) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie
folgt geändert:
 - a. Nach der Angabe zu § 5
wird folgende Angabe
eingefügt:
„§ 5a Besonderer
Sicherungs- und
Transformationsbedarf“.
 - b. Nach der Angabe zu § 10
wird folgende Angabe
eingefügt:
„§ 10a Verfahren zur
Sicherung
versorgungsnotwendiger
Standorte und
Leistungsbereiche“.

2. In § 1 Absatz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „organisiert“ die Wörter „, auch durch sektorenübergreifende Versorgungsformen, regionale Kooperationsstrukturen und besondere Sicherungsmaßnahmen für dünn besiedelte und strukturschwache Räume,“ eingefügt.

3. Dem § 1 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Öffentliche und gemeinwohlorientierte Träger sind bei der Sicherung versorgungsnotwendiger Krankenhausstandorte besonders zu berücksichtigen.“

4. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:
„§ 5a
Besonderer Sicherungs- und Transformationsbedarf

(1) Der Krankenhausplan kann Krankenhäuser, Krankenhausstandorte oder Leistungsbereiche als besonders sicherungsbedürftig ausweisen, wenn ihre Vorhaltung für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, insbesondere in dünn besiedelten oder

strukturschwachen Räumen, wesentlich ist.

(2) Der Krankenhausplan kann ferner Standorte oder Leistungsbereiche mit besonderem Transformationsbedarf ausweisen, wenn deren dauerhafte Sicherung nur durch Umstrukturierung, Verbundbildung, Trägerwechsel oder sektorenübergreifende Weiterentwicklung erreicht werden kann.

(3) Besonders sicherungsbedürftige Leistungsbereiche sind insbesondere Geburtshilfe, Pädiatrie, Notfallversorgung und ländliche Grundversorgung.

(4) Festlegungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind bei Entscheidungen nach dem Ostdeutschen Krankenhaussicherungs- und Rekommunalisierungsfondsgesetz besonders zu berücksichtigen.“

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Krankenhausträger sind verpflichtet, dem

zuständigen
Staatsministerium
unverzüglich, spätestens
jedoch zwölf Monate vor
der beabsichtigten
Umsetzung, anzuzeigen:

1. die
Einstellung des
Betriebs eines
Krankenhauses
oder eines
Krankenhausstando-
ortes,
2. die
wesentliche
Einschränkung des
Versorgungsauftrag-
s,
3. die Änderung
der
Aufgabenstellung,
4. den
Trägerausstieg,
5. die
Veräußerung einer
beherrschenden
Beteiligung an der
Trägersgesellschaft
oder wesentlicher
betriebsnotwendig-
er
Vermögensgegenst-
ände, soweit

hierdurch die
Erfüllung des
Versorgungsauftrag-
s gefährdet werden
kann.

Das zuständige
Staatsministerium beteiligt
den
Krankenhausplanungsauss-
chuss und stellt
gegenüber dem
Krankenhausträger
innerhalb von sechs
Monaten nach Eingang
der vollständigen Anzeige
fest, ob die Maßnahme
krankenhausplanerisch
bedenklich ist. Die
Maßnahme darf nur
umgesetzt werden, wenn
innerhalb dieser Frist
keine Bedenken
festgestellt worden sind.
Andernfalls ist der
Versorgungsauftrag bis zu
einer anderweitigen
Entscheidung nach § 10a
weiter zu erfüllen, soweit
dem nicht zwingende
insolvenzrechtliche
Gründe entgegenstehen.“

- b. Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 eingefügt:

„(2) Die Anzeige nach Absatz 1 muss die Gründe der Maßnahme, den vorgesehenen Zeitplan, die wirtschaftliche Lage, die Auswirkungen auf die regionale Versorgung und ein Konzept zur Sicherung oder geordneten Überleitung der Versorgung enthalten.

(3) Bei besonders sicherungsbedürftigen Krankenhäusern, Krankenhausstandorten oder Leistungsbereichen kann das zuständige Staatsministerium die Vorlage ergänzender Unterlagen verlangen und die betroffenen Landkreise, kreisfreien Städte sowie mögliche öffentliche oder gemeinwohlorientierte Träger zu einer Sicherungslösung anhören.“

- c. Die bisherigen Absätze 2 bis 3 werden zu den Absätzen 4 und 5.

6. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a

Verfahren zur Sicherung versorgungsnotwendiger Standorte und Leistungsbereiche

(1) Ist ein Krankenhaus, ein Krankenhausstandort oder ein Leistungsbereich versorgungsnotwendig und liegen Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung vor, kann das zuständige Staatsministerium ein Verfahren zur Sicherung der Versorgung einleiten.

(2) Im Verfahren nach Absatz 1 sind insbesondere zu prüfen:

1. die Fortführung durch den bisherigen Träger,
2. die Übernahme durch kommunale oder gemeinwohlorientierte Träger,
3. die Einbindung in einen interkommunalen oder regionalen Klinikverbund,
4. die vorübergehende Stabilisierung oder

Übernahme nach dem
Ostdeutschen
Krankenhaussicherungs-
und
Rekommunalisierungsfond
sgesetz.

(3) Das zuständige
Staatsministerium kann hierzu die
betroffenen Landkreise,
kreisfreien Städte, kommunalen
Zweckverbände und sonstigen
geeigneten Träger beteiligen und
koordinierende Gespräche
führen.

(4) Feststellungen nach Absatz 1
und Entscheidungen im

Verfahren nach den Absätzen 2
und 3 begründen für sich allein
keinen Anspruch auf bestimmte
Leistungen aus dem
Ostdeutschen
Krankenhaussicherungs- und
Rekommunalisierungsfondsgesetz
; sie sind dort jedoch vorrangig
zu berücksichtigen.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf
die Verkündung folgenden Monats in
Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT